病毒性角膜内皮炎

2023共识 · 眼科临床速查

正面 · 诊断与处置

诊断与病原检查〔2023 p14–15〕

临床：依据1（急性起病；感染史/免疫下降诱因可有）＋3（基质水肿、水肿区KP、后弹力层皱褶）。病因：依据1、3及4或5。4为IVCM，猫头鹰眼对应CMV，非任意IVCM异常即可定病原；5为PCR阳性。**PCR阴性不能排除**，必要时补充房水特异抗体/G-W。

重点风险与鉴别〔2023 p15–16〕

线状型内皮丢失最快、易失代偿；关注眼压和内皮变化。鉴别前葡萄膜炎、基质炎、Fuchs/Chandler、移植排斥及急闭。正式危险分层、PCR和眼压处置阈值：**原文未明确**。

病原与局部抗病毒〔2023 p16–17〕

HSV：阿昔洛韦或更昔洛韦；CMV：首选更昔洛韦，**阿昔洛韦无效**；VZV：全身更昔洛韦/泛昔洛韦或更高剂量阿昔洛韦（确切量**原文未明确**），局部更昔洛韦。0.15%凝胶或0.1%更昔洛韦滴眼液4~6次/d；痊愈后2次/d，2~4周。

激素、眼压、手术〔2023 p17〕

在**有效抗病毒基础上**联合：1%醋酸泼尼松龙或妥布霉素地塞米松滴眼液4次/d。羊脂/尘状KP消退后，每周减1次，至1次/d后按炎症调整。关注眼压；升高需降压，正常后减停，**慎用前列腺素类**。严重失代偿评估移植；术前后充分抗病毒，术后全身用药通常3~6个月。

---

p为期刊页码（PDF页码=p−12）。剂量为2023原文摘录，开药前核对。完整证据与研究区别见提取表。

打印：100% 原尺寸 · 双面长边翻转

病毒性角膜内皮炎

2023共识 · 眼科临床速查

背面 · 用药与随访

成人全身剂量摘录〔2023 p16〕

阿昔洛韦200 mg/次，5次/d，7 d；缓解后400 mg/d，4~6个月（原文称“诱导剂量”）。伐昔洛韦500 mg/次，2次/d，7 d。更昔洛韦诱导：口服1 g/次、3次/d或慢速静滴250 mg/次、1次/12 h，均14 d；维持口服0.5 g/次、3次/d，2个月。泛昔洛韦口服0.25 g/次、3次/d，7 d。

更昔洛韦监测与停药〔2023 p16〕

用前血常规/肝肾。诱导：血常规每3 d、肝肾每周；维持：血常规每周、肝肾每2~4周。**停药：肝肾恶化；血小板≤25×10⁹/L；粒细胞≤0.5×10⁹/L或降至用前50%**。3周无效考虑耐药，改膦甲酸钠（二线、肾毒性，剂量**原文未明确**）。

特殊人群与慎用〔2023 p16〕

儿童：阿昔洛韦10~15 mg/(kg · d)，分3~5次、7 d；更昔洛韦5 mg/(kg · 次)，诱导2次/d、14 d，维持1次/d、2个月；儿童途径**原文未明确**。**肾损伤避免阿昔洛韦**；泛昔洛韦按肾功能调整（分档**原文未明确**）；**骨髓移植慎用更昔洛韦**。

随访缺项〔2023 p14、17〕

关注KP/炎症、眼压、内皮细胞变化及药物化验。统一复诊间隔、妊娠/哺乳方案、正式推荐等级：**原文未明确**。CMV易复发者适当延长治疗；避免劳累、感冒，加强锻炼。

---

p为期刊页码（PDF页码=p−12）。剂量为2023原文摘录，开药前核对。完整证据与研究区别见提取表。

打印：100% 原尺寸 · 双面长边翻转